Dr. Juan David Riveros – Neurología Hospital Tony Facio

Tipo de consulta	Diagnósticos	Definición/Requisitos	Información adicional
General	Migrañas crónicas	Pacientes con cefaleas primarias quienes no logran control luego de un abordaje básico en atención primaria No corresponden a esta consulta: 1. Sospechas de cefaleas secundarias (corresponden al servicio de emergencias) 2. Cefaleas primarias que no cumplan los requisitos Requisitos (deben estar claros en la referencia) 1. Descripción adecuada del tiempo de evolución y la semiología de la cefalea enfatizando en la ausencia de banderas rojas en la historia clínica y en el examen físico (debe incluir descripción de fondo de ojo) 2. Implementación de medidas no farmacológicas correctivas 3. Fallo al tratamiento demostrado (requiere confirmar buena adherencia al tratamiento luego de 3 meses de máxima dosis tolerada de medicación apropiada (ver columna de información adicional) 4. Descartar cefalea por sobreuso de analgésicos, opioides (incluidos tramal y codeína) y ergotamínicos y sus derivados	Sugiero lectura de Manual de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología Debe intentarse llevar paciente a las siguientes dosis según tolerancia (de forma paulatina, sugiero no mezclar medicaciones para evitar efectos adversos) Amitriptilina hasta 75 mg/día, Propranolol hasta 160 mg/día y/o Valproato hasta 1500 mg/día
	Cefalea tensional crónica		
	Cefaleas autonómicas		Verapamilo hasta 960 mg/día
	Neuralgia del trigémino		Carbamazepina hasta 1200 mg/día
	Neuropatías	Pacientes con diagnósticos de neuropatías sin etiología clara No corresponde a esta consulta 1. Pacientes con etiología clara que pueda manejarse en atención primaria u otra especialidad afín 2. Control sintomático del dolor neuropático Requisitos: 1. Laboratorios generales 3. Glicada, B12, VIH, VDRL, función tiroidea, VES	Si la etiología está clara y solo requiere control sintomático del dolor neuropático, podrá continuar control según criterio de neurólogo en atención primaria, fisiatría y/o cuidados paliativos El seguimiento de las limitaciones secundarias a la debilidad corresponde a rehabilitación
	Miopatías	Pacientes con diagnóstico de miopatías sin etiología clara No corresponde a esta consulta 1. Pacientes con etiología clara 2. Pacientes con miopatías inflamatorias (corresponden a reumatología) 3. Solicitud de biopsias musculares Requisitos: 1. Laboratorios generales, VES, CPK	Las miopatías inflamatorias corresponden a reumatología El seguimiento de las limitaciones secundarias a la debilidad corresponde a rehabilitación

	Vértigo	Pacientes con secuelas de un vértigo central sin etiología clara. No corresponden a esta consulta 1. Vértigo agudo (corresponde al SEM) 2. Vértigo periférico (corresponden a ORL) 3. Lipotimias/síncopes cardiogénicos Requisitos (deben estar claros en la referencia) 1. Descripción detallada de la semiología del vértigo y el HINTS 2. En caso de vértigos asociados a cambios de posición, Valsalva o actividad física debe descartarse hipotensión ortostática y bradiarritmias 3. Idealmente referir con neuroimagen cerebral realizada (no es necesario el reporte)	Sugiero lectura e implementación del HINTS El seguimiento de las limitaciones secundarias al vértigo corresponde a rehabilitación
	Primer evento sospecha epiléptico	Pacientes con sospecha de primer evento convulsivo Se deben enviar al servicio de emergencias para descartar causas provocadas y neuroimagen. Una vez descartadas las causas provocadas, idealmente valoración por neurología en el SEM (o por medicina interna/geriatría en su ausencia) y referir a esta consulta. No corresponden a esta consulta 1. Pacientes con primer evento convulsivo con causa provocada clara Requisitos (deben estar claros en la referencia) 1. Descripción apropiada de la semiología del evento 2. Valoración previa que descarte causas provocadas corregibles 3. Laboratorios generales 4. Neuroimagen cerebral Importante: en el caso de haber presentado una única crisis epiléptica que no fue valorada en el SEM, indicar a paciente que en caso de recurrencia consulte al SEM para definir caso ahí. Estos pacientes no deben ser enviados a la consulta externa sin estudios pues pueden tener patologías graves y deben definirse rápidamente desde el SEM.	Causas provocadas incluyen, pero no se limitan a: lesiones espacio ocupantes cerebrales, hidrocefalias, síndrome de abstinencia, intoxicaciones agudas, trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, hipocalcemia, hipercalcemia, encefalopatía urémica, encefalopatía hepática, sepsis, entre otros
	Epilepsia	Pacientes epilépticos con buen control de la epilepsia, pero sin etiología definida No corresponden a esta consulta:	Causas provocadas incluyen, pero no se limitan a: lesiones espacio ocupantes cerebrales, hidrocefalias, síndrome de

		1. Buen control crónico con 1-2 fármacos anticrisis y con etiología clara (corresponde a primer nivel de atención) 2. Epilepsias farmacorresistentes o antecedentes de estatus epiléptico (corresponden a consulta de epilepsia farmacorresistente) Requisitos: 1. Descripción detallada de los fármacos que usa el paciente, las dosis que usa y la frecuencia de crisis 2. Laboratorios generales 3. Idealmente con alguna neuroimagen previa	abstinencia, intoxicaciones agudas, trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, hipocalcemia, hipercalcemia, encefalopatía urémica, encefalopatía hepática, sepsis, entre otros
	Síndrome de debilidad neuromuscular	Grupo muy heterogéneo de patologías de distintas topografías y etiologías. Si no tienen un diagnóstico u orientación clara serán atendidos en consulta general. No corresponden a esta consulta 1. Fatiga sin debilidad 2. Según el tiempo de evolución y la afectación de musculatura bulbar corresponde al SEM Requisitos: 1. Descripción general del tiempo de evolución y la afectación que genera la deblidad 2. Todos con laboratorios generales 3. Según sospecha: función tiroidea, glicada, HIV, VDRL, VES, ANA, B12, punción lumbar, estudios de imagen	El seguimiento de las limitaciones secundarias a la debilidad corresponde a rehabilitación
	Trastornos de la marcha	Grupo muy heterogéneo de patologías de distintas topografías y etiologías. Si no tienen un diagnóstico u orientación clara serán atendidos en consulta general. No corresponde a esta consulta 1. Trastornos de la marcha agudos (corresponde al SEM) o postraumáticos (corresponde a ortopedia o neurocirugía según el lugar del trauma) Requisitos: 1. Descripción del tiempo de evolución y la afectación que genera el trastorno de la marcha 2. Laboratorios generales 3. Según sospecha puede requerir glicada, HIV, VDRL, VES, ANA, B12, punción lumbar, estudios de imagen	El seguimiento de las limitaciones secundarias al trastorno de la marcha corresponde a rehabilitación

	Sospecha primer brote enfermedad desmielinizante incluyendo neuritis óptica	Pacientes con sospecha de primer brote de enfermedad desmielinizante deben ser referidos al servicio de emergencias para valoración por neurología (o en su ausencia medicina interna). Se atenderán en esta consulta pacientes que tienen la historia sugestiva de un primer brote, pero por la razón que sea, no se definió la etiología y/o no quedaron con un seguimiento o control en neurología Requisitos: 1. Descripción detallada del tiempo de duración y la semiología del evento 2. Laboratorios generales 3. Según sospecha pueden requerir PFT, glicada, HIV, VDRL, VES, ANA, B12, serologías por HSV, CMV, VEB y toxoplasma 4. Según sospecha requiere valoración previa por oftalmología y/o OCT	Lo ideal es atender estos pacientes con el primer brote desde el SEM, pero en ocasiones paciente no consulta o no se definió apropiadamente desde el SEM. Esto es una excepción y no la regla.
Trastornos del movimiento	Enfermedad de Parkinson Otros parkinsonismos Otros trastornos del movimiento	Pacientes con enfermedad de Parkinson u otros parkinsonismos, así como otros trastornos del movimiento (coreas, balismos, atetosis, tics, tremor, entre otros). Requisitos 1. Descripción detallada del tiempo de evolución y la semiología del trastorno del movimiento. 2. Laboratorios generales 3. B12, HIV, VDRL 4. PFT en el caso del tremor	El seguimiento de las limitaciones secundarias al trastorno del movimiento corresponde a rehabilitación
Autoinmunes	Esclerosis múltiple Neuromielitis óptica MOGAD Encefalitis autoinmune Síndromes paraneoplásicos Guillain Barré y sus variantes CIDP y sus variantes Síndromes miasténicos	Pacientes con diagnósticos confirmados o alta sospecha de esclerosis múltiple NMO, MOGAD, encefalitis autoinmune, síndromes paraneoplásicos, Guillain-Barré y sus variantes, CIDP y sus variantes, síndromes miasténicos Estos pacientes deben ser idealmente valorados en SEM por neurología (o en su ausencia medicina interna o geriatría) donde se definirán los estudios que requiere el paciente y si se hacen ambulatoriamente o en internamiento. Requisitos 1. Laboratorios generales 2. Laboratorios adicionales, PL y neuroimagen según sospecha (pueden requerir PFT, glicada, HIV, VDRL, VES, ANA, B12, serologías por HSV, CMV, VEB y toxoplasma, AQP4/MOG, OCT, valoración por oftalmología	Lo ideal es atender estos pacientes desde el SEM, pero en ocasiones paciente no consulta o no se definió apropiadamente desde el SEM. Esto es una excepción y no la regla El seguimiento de las limitaciones secundarias a la debilidad corresponde a rehabilitación
Cognitivo joven	Deterioro cognitivo leve (DCL) y	DCL o síndrome demencial en menores de 65 años que no tengan un diagnóstico definido	El seguimiento de las limitaciones secundarias a la debilidad/trastorno del

	síndromes demenciales en menores de 65 años	No corresponden a esta consulta 1. Pacientes con sospecha de etiología afectiva (corresponde psiquiatría) 2. Pacientes con etiología clara (seguimiento sintomático con psiquiatría) 3. Pacientes mayores de 65 años (corresponde a geriatría) Requisitos: 1. Descripción detallada de la queja cognitiva que presenta 2. Laboratorios generales, PFT, B12, HIV, VDRL, VES 3. Según la sospecha requiere neuroimagen cerebral 4. Según sospecha requiere previa valoración por psicología/psiquiatría Importante: la queja subjetiva de la memoria y quejas aisladas de inatención son muy frecuentes en pacientes con epilepsia mal controlada o patología afectiva (depresión/ansiedad) por lo que estos se aceptarán según cada caso particular si hay sospecha de otra etiología que no sea afectiva o por la epilepsia mal controlada	movimiento/marcha corresponde a rehabilitación El seguimiento de los síntomas neuropsiquiátricos corresponde a psiquiatría
Vascular	Isquemia cerebral transitoria ECV isquémico evolucionado ECV isquémico sometido a terapia de reperfusión	Pacientes con ICT o ECV isquémicos sin etiología clara tras una valoración razonable Paciente que haya sido sometido a una terapia de reperfusión (trombolisis, trombectomía o endarterectomía) con o sin etiología definida No corresponden a esta consulta: 1. Pacientes con etiología clara de la ICT o del ECV que no hayan sido sometidos a terapias de reperfusión (corresponde a prevención secundaria en primer o segundo nivel de atención) 2. Pacientes con factores de riesgo cardiovascular con hallazgos asintomáticos en neuroimágenes de enfermedad de pequeño vaso (corresponde a prevención primaria en primer o segundo nivel de atención) Requisitos mínimos: 1. Laboratorios generales, glicada, lípidos, VES, HIV, VDRL, PFT, B12, EKG, neuroimagen 2. En personas menores de 55 años, agregar estudios por vasculitis, LES y SAF	Lo ideal es atender estos pacientes desde el SEM, pero en ocasiones paciente no consulta o no se definió apropiadamente desde el SEM. Esto es una excepción y no la regla Todos los pacientes deben ser referidos también a medicina general, medicina interna, medicina familiar o comunitaria y/o geriatría para el control, seguimiento y optimización de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos ya que esto no se realiza en la CE de neurología. El seguimiento de las limitaciones secundarias al ECV corresponde a rehabilitación
	ECV hemorrágico	Pacientes con ECV hemorrágico hipertensivo reciente (menos de 3 meses) y todo paciente con ECV hemorrágico lobar a quien se le hayan descartado causas secundarias de forma razonable en el SEM o durante internamiento	Lo ideal es atender estos pacientes desde el SEM, pero en ocasiones paciente no consulta o no se definió apropiadamente

		Requisitos mínimos: 1. Laboratorios generales, glicada, lípidos, EKG, neuroimagen	desde el SEM. Esto es una excepción y no la regla El seguimiento de las limitaciones secundarias al ECV corresponde a rehabilitación
	Trombosis venosa cerebral	Pacientes con diagnóstico de trombosis venosa cerebral reciente (con o sin etiología clara) o trombosis venosa cerebral antigua sin etiología clara. Pacientes que continúan con anticoagulación y se necesita definir si la mantiene o no. Requisitos: 1. Laboratorios generales, glicada, lípidos, EKG, neuroimagen 2. Estudios por SAF y trombofilias genéticas No corresponden a esta consulta 1. Trombosis venosas cerebrales con etiología (excepto si son recientes)	Lo ideal es atender estos pacientes desde el SEM, pero en ocasiones paciente no consulta o no se definió apropiadamente desde el SEM. Esto es una excepción y no la regla El seguimiento de las limitaciones secundarias al ECV corresponde a rehabilitación El seguimiento de la anticoagulación corresponde a anticoagulados
Epilepsia farmacorresistente	Epilepsias farmacorresistentes Antecedente de estatus epilépticos	Pacientes epilépticos (cualquier tipo) sin etiología clara y con mal control crónico a pesar de 3+ fármacos anticrisis adecuadamente seleccionados o dosis correctas y quien tiene buena adherencia a la medicación Pacientes con antecedentes de estatus epiléptico No corresponden a esta consulta 1. Buen control crónico con 1-2 fármacos anticrisis y con etiología clara (corresponde a primer o segundo nivel de atención) 2. Pacientes con buen control, pero sin etiología clara (corresponde consulta general neurología) Requisitos: 1. Descripción detallada de los fármacos que usa el paciente, las dosis que usa y la frecuencia de crisis 2. Laboratorios generales 3. Idealmente con alguna neuroimagen previa 4. Según sospecha de crisis funcionales valoración previa por psicología/psiquiatría	Es imprescindible confirmar buena adherencia al tratamiento. Sugiero que si hay sospecha o confirmación de mala adherencia se valore por Atención Farmacéutica
ATP	Cualquier diagnóstico	Pacientes que tengan visto bueno expreso del Dr. Riveros. El objetivo de esta atención prioritaria es valorar pacientes que requieran una atención más	Únicamente pacientes con visto bueno explícito del Dr. Riveros

		expedita que el de la consulta normal (valorar respuesta a tratamientos, valoración de reportes de estudios importantes, valoración luego de sometimiento de terapia de reperfusión o alguna inmunoterapia, etc.)	
Procedimientos	Cualquier diagnóstico	Pacientes seleccionados por el Dr. Riveros para procedimientos como: punción lumbar, prueba de Fisher, realización de escalas cognitivas (MoCA y MMSE), realización de escalas motoras de seguimiento (UPDRS, EDSS, digit-span, 9-hole peg test), prueba de levodopa, ultrasonidos carotídeos, Doppler transcraneal, prueba de burbujas, revisión detallada de neuroimágenes que modifiquen el manejo de los pacientes, ecoscopías, entre otros	